RESUMEN EPICRISIS

PACIENTE: AMBEREEM JACDIEL RAMOS BRACHO	**IDENTIFICACION:** MS VEN000316	**HC:** VEN000316 - MS
FECHA DE NACIMIENTO: 8/3/2018 **EDAD:** 8 Años **SEXO:** M		**TIPO AFILIADO:** Otro
RESIDENCIA:	VALLE DEL CAUCA-CALI	**TELEFONO:** 43
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A)	**OCUPACIÓN:**	
NOMBRE ACOMPAï¿½ANTE:	**PARENTESCO:**	**TELEFONO:**
FECHA INGRESO: 08/03/2026 03:43 PM	**FECHA EGRESO:**	**CAMA:** UCP308
DEPARTAMENTO: UCIPED - UCI PEDIATRICA	**SERVICIO:** U.C.I.	
CLIENTE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**PLAN:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. 2026 - SOAT	

FECHA	MOTIVOS DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL
2026-03-08	**17:37 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ** **CAUSA QUE MOTIVA LA ATENCIÓN:** Accidente de transito de origen comun **MOTIVO DE CONSULTA :** ACCIDENTE DE TRANSITO **ENFERMEDAD ACTUAL :** TRAUMA SEVERO EN REGION ANTERIOR DE PIERNA DERECHA CON HERIDA COMPLEJA Y FRACTURA ASOCIADA

DIAGNOSTICOS DE INGRESO ASIGNADOS

CODIGO	DIAGNOSTICO DE INGRESO	ESTADO	OBSERVACION	USUARIO	FECHA
S817	HERIDAS MULTIPLES DE LA PIERNA			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-08
S822	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA			FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	2026-03-08
S824	FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-08

MOTIVO DE SALIDA Y RECOMENDACIONES

2026-03-08 17:37 **PROFESIONAL:** julgraor - JULIANA GRAJALES ORTIZ **ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

INGRESO URGENCIAS PEDIATRIA

NOMBRE: NN (AMBRE)
EDAD: 8 AÑOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: VEN000316
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE:JULIER BRACHO DE 21.141181 (MADRE)
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS:08/03/2026

MOTIVO DE CONSULTA: "ACCIDENTE DE TRÁNSITO"

ENFERMEDAD ACTUAL:
INGRESA PACIENTE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL PARAMÉDICO Y MADRE EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO CARRO PASA POR ENCIMA DE LA PIERNA Y PRODUCE TRAUMA EN PIERNA DERECHA CON HERIDA PROFUNDA, CON COMPROMISO VASCULAR, EXPOSICION OSEA, LIMITACION DE LOS ARCOS DE MOVILIDAD DOLOR CON INTENSIDAD 10/10 SEGUN EVA.

SIN ESTIGMAS DE TRAUMA A OTROS NIVELES. NIEGA TRAUMA CRANEOENCEFALICO, TORACICO Y ABDOMINAL.

REVISIÓN POR SISTEMAS: NIEGA

ANTECEDENTES:
*PATOLÓGICOS NIEGA
*FARMACOLÓGICOS NIEGA
*QUIRÚRGICOS NIEGA
*HOSPITALIZACIONES: NIEGA
*TRANSFUSIONES: NIEGA
*ALERGIAS NIEGA
*PERINATALES : NIEGA
VACUNAS: DESCONOCIDOS

PROTOCOLO COVID:
1. ¿HA TENIDO SÍNTOMAS RESPIRATORIOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
2. ¿HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
3. ¿HA TENIDO CONTACTO CON ALGÚN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO PARA COVID? NIEGA.

PROTOCOLO ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS:
HA PRESENTADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:
-FIEBRE O MÁS? NIEGA.
-TOS POR MÁS DE 15 DÍAS? NIEGA.
-CEFALEA? NIEGA.
-PÉRDIDA DEL GUSTO Y EL OLFATO? NIEGA.
-CONJUNTIVITIS? NIEGA.
-CRECIMIENTO DE GANGLIOS LINFÁTICOS? NIEGA.
-LESIONES EN PIEL: MÁCULAS, PÁPULAS, VESÍCULAS, PÚSTULAS O ÚLCERAS GENITALES? NIEGA.

1. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 21 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
2. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS SE HA DESPLAZADO A ZONAS ENDÉMICAS PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
3. ¿VIVE USTED O SE HA ENCONTRADO EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO? NIEGA.
4. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO (< A 1 METRO DE DISTANCIA) CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA COVID 19? NIEGA.
5. ¿ES TRABAJADOR DE LA SALUD? NIEGA
6.¿ES TRABAJADOR DEL SECTOR AVÍCOLA O PORCINO ? ¿ O HA ESTADO EN CONTACTO CON AVES O CERDOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA
7.¿ HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS A ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE VIRUS DE INFLUENZA AVIAR O AGENTES RESPIRATORIOS NUEVOS CON POTENCIAL PANDÉMICO? NIEGA
8. ¿ HA ESTADO EN CONTACTO CON PERSONAS O GRUPOS SOCIALES(ENTORNOS FAMILIARES,LUGAR DE TRABAJO, COLEGIOS,UNIVERSIDADES, CÁRCEL, BATALLÓN) CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS? NIEGA

CONCILIACIÓN MEDICAMENTOSA: NIEGA

EXAMEN FÍSICO: SE VALORA A PACIENTE CON AUTORIZACIÓN DE FAMILIAR , CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD.

PRESIÓN ARTERIAL 123/82 MMHG, FRECUENCIA CARDIACA DE 112 LATIDOS POR MINUTO, SATURACIÓN DE OXIGENO DEL 96% AL AIRE AMBIENTE, TEMPERATURA DE 36°C, CON UNA FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 19 RESPIRACIONES POR MINUTO, Y UN GLASGOW DE 15/15

ANTROPOMETRÍA

PESO: 25 KILOS APROX

CABEZA Y CUELLO: SIN MASAS NI HUNDIMIENTOS PUPILAS ISOCORICAS FOTORREACTIVAS ESCLERAS ANICTERICAS MUCOSAS HUMEDAS OROFARINGE SIN ERITEMA SIN PLACAS SIN ESCURRIMIENTO POSTERIOR OTOSCOPIA BILATERAL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO PERMEABLE SIN ERITEMA MEMBRANA TIMPANICA NO ABOMBADA CUELLO MOVIL SIMETRICO SIN MASAS NI ADENOPATIAS SIN ESTIGMAS DE TRAUMA

TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE MURMULLO VESICULAR PRESENTE SIN SOBREAGREGADOS A LA AUSCULTACION RUIDOS CARDIACOS RITMICOS REGULARES NO SE AUSCULTAN SOPLOS

ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE SIN MASAS NI ADENOPATIAS NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL SIN ESTIGMAS DE TRAUMA

GENITOURINARIO NORMOCONFIGURADO SIN ESTIGMAS DE TRAUMA

EXTREMIDADES: EN PIERNA DERECHA HERIDA COMPLEJA ANTERIOR Y POSTERIOR, CON EXPOSICION OSEA, CIONOSIS, DISMINUCION DE LOS PULSOS, FRIALDAD, LLENADO CAPILAR MAYOR DE 3 SEGUNDOS. RESTO DE EXTREMIDADES MOVILES, SIMETRICAS, SIN EDEMAS, PULSOS PRESENTES,LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEGUNDOS.

NEUROLOGICO ALERTA ORIENTADO SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO SIN SIGNOS DE FOCALIZACION NEUROLOGICA

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:
ESCOLAR MASCULINO
TRAUMA EN PIERNA DERECHA
FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA DERECHA
HERIDA COMPLEJA EXTENSA EN REGION ANTERIOR DE PIERNA Y HERIDA EN REGION POSTERIOR
ACCIDENTE DE TRANSITO

ANÁLISIS/PLAN:
PACIENTE QUIEN INGRESA A NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON TRAUMA EN PIERNA DERECHA CON FRACTURA EXPUESTA, HERIDA COMPLEJA EXTENSA EN REGION ANTERIO Y POSTERIOR, CON SIGNOS DE COMPROMISO VASCULAR, INGRESA ALERTA, CONCIENTE, ALGICO, SE INGRESA A SALA DE REANIMACION, SE INICA REANIMACION HIDRICA, ANALGESICO Y TOMA DE ESTUDIOS, PARA POSTERIOR TRASALDO A UCIP, SE COMENTA CON CX VASCULAR Y ORTOPEIA INFANTIL, SE LE EXPOLICA A MADRE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

ORDENES MÉDICAS**

-TRASALDO A UCIP
-NADA VIA ORAL
-CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-CONTROL DE SIGNOS VITALES
-INFORMAR CAMBIOS

MEDICAMENTOS:
PESO 25 KG
-LEV SSN 250 ML EN BOLO PASR EN 30 MIN
-MORIFNA AMP 10 MG, ADM 1.2 MG EV AHORA
-DIPIRONA AMP 1 GR, ADM 375 MG EV AHORA
-TOXOIDE TETANICO IM AHORA
-AMPICILINA /SULBACTAM AMP 1.5GR, ADM 1.5 GR EV CADA 8 HR FI: 08/03/2026

SE SOLICITA:
-IMÁGENES DIAGNÓSTICAS: TAC DE MIEMBROS INFERIORES, RADIOGRAFIA DE PIERNA DERECHA
-PARA SANGRAR: HEMOGRAMA, TIEMPO, BUN, CR, ELCTROLITOS CPK
-VALORACION POR CX VSCULAR
-VALORACION POR ORTOPEDIA INFANTIL

SEGUIMIENTO:
-PEDIATRÍA/MEDICINA GENERAL

2026-03-08 17:43	**PROFESIONAL:** julgraor - JULIANA GRAJALES ORTIZ	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

*** NOTA ADICIONAL**

NOMBRE: NN (AMBRE)
EDAD: 8 AÑOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: VEN000316
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE:JULIER BRACHO DE 21.141181 (MADRE)
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS:08/03/2026

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:
ESCOLAR MASCULINO
TRAUMA EN PIERNA DERECHA
FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA DERECHA
HERIDA COMPLEJA EXTENSA EN REGION ANTERIOR DE PIERNA Y HERIDA EN REGION POSTERIOR
ACCIDENTE DE TRANSITO

REPORTE DE IMAGENES: RX DE PIERNA DERECHA: FX DE TIBIA Y PERONE DERECHA ** NO REPORTE OFICIAL**
ANGIO TAC DE PIERNA DERECHA: FLUJO PERMEBALE DE LA TIBIA POSTERIOR, TIBIAL ANTERIOR, EN EL TERCIO DISTAL DE LA PIERNA SE OBSERVA DISMINICION DEL FLUJO DE LA ARTERIA PERONE. ** REPORTE NO OFICIAL**

PACIENTE QUIEN SUFRE ACCDIENTE DE TRANSITO CON TRAUAM EN PIERNA DERECHA, SE COMENTA CASO CON CX VASCULAR QUIEN REFIERE QUE OBSERVA DISMUNUCION DEL FLUJO DE LA ARTERUA PERONE EL CUAL ES CONDUCTA ESPECTANTE, POR AHORA CONTROL DE DAÑOS POR PARTE DE ORTOPEDIA INFANTIL A LA ESPERA DE RESPUESTA, SE LE EXPLICA A MADRE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

2026-03-08 17:44	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

INGRESO A UCIP

NOMBRE: NN-NN (AMBER JACDIEL BRACHO MEDOZA)
EDAD: 8 AÑOS
IDENTIFICACION: MS-VEN000316
FECHA DE NACIMIENTO: 08/03/2018
ORIGEN: VENEZUELA.
PROCEDENCIA: CALI - VALLE
ENTIDADA: SOAT
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 08/03/2026
FECHA DE INGRESO A UCIP: 08/03/2026

*MOTIVO DE CONSULTA: ACCIDENTE DE TRANSITO.

*ENFERMEDAD ACTUAL: EL NIÑO INGRESO AL SERVICION DE URGENCIAS EN COMPAÑÍA DE PERSONAL PARAMÉDICO Y DE SU MADRE, EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO. AL PARECER UN CARRO LE PASO POR ENCIMA DE LA PIERNA DERECHA GENERANDOLE TRAUMA GRAVE POR APLASTAMIENTO EN DICHA EXTREMIDAD. CON SOSPECHA DE COMPROMISO VASCULAR, EXPOSICION USCULAR Y OSEA. LIMITACION DE LOS ARCOS DE MOVILIDAD DOLOR INTENSO.

SIN ESTIGMAS DE TRAUMA A OTROS NIVELES. NIEGA TRAUMA CRANEOENCEFALICO, TORACICO Y ABDOMINAL.

*REVISION POR SISTEMAS: PREVIAMENTE SANO.

*ANTECEDENTES.
-PATOLOGICOS: NINGUNO CONOCIDO.
-QUIRURGICOS: NINGUNO
-ALERGICOS: NINGUNO CONOCIDO
-VACUNAS: SIN INFORMACION OBJETIVA
-EPIDEMIOLOGICOS: SIN NOXA DE CONTAGIO
-FAMILIARES: SIN INFORMACION

*CONCILIACION MEDICAMENTOSA: NINGUNA.

*OBJETIVO:
FC: 115/MIN. TA: 132/90/100. FR: 25/MIN. SO2: 98% CON FIO2 DEL 21%. T: 36 °C. GLUCOMETRIA: 158 MG/DL.
NEUROLOGICO: ALERTA, PUPILAS A 3 MM REACTIVAS, MOVIMIENTOS OCULARES NORMALES. SIN SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA NI FOCALIZACION.
ORL: SIN ALETEO NASAL, QUEJIDO NI ESTRIDOR. BOCA HUMEDA.
CUELLO: LLENADO YUGULAR NORMAL. SI MASAS. MOVIL E INDOLORO.
TORAX: TAQUIPNEICO, EXPANSIBILIDAD SIMETRICA, SIN RETRACCIONES.
PULMONES: MURMULLO VESICULAR NORMAL. SIN AGREGADOS.
CARDIOVASCULAR: TAQUICARDICO, EN SINUSAL, SIN SOPLOS, PULSOS NORMALES, LL. CAPILAR <2S, HIPERTENSO, EUTERMICO.
ABDOMEN: PERISTALTISMO NORMAL, BLANDO, INDOLORO. SIN DISTENSION, ASCITIS, MASAS NI MEGALIAS.
RENAL: HIDRATADO, EUVOLEMICO, SIN EDEMA. GASTO URINARIO NO CUANTIFICADO.
HEMATOLOGICO: SIN SANGRADO ACTIVO NI SIGNOS DE COAGULOPATIA.
INFECCIOSO: AFEBRIL, RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA REGULADA.
OSTEOMUSCULAR: DEFORMIDAD DE LA PIERNA DERECHA. GRAN HERIDA LONGITUDINAL PRETIBIAL POR APLASTAMIENTO CON ESTALLIDO DE PIEL Y EXPOSICION DE TEJIDO MUSCULAR, QUE COMPROMETE DESDE LA TUBEROSIDAD TIBIAL ANTERIOR HASTA LA ARTICULACION DEL TOBILLO DE LA PIERNA DERECHA. SIN SANGRADO ACTIVO. COLORACION VIOLACEA DEL DORSO DEL PIE DERECHO CON LLENADO CAPILAR EN 3 S.

*ANALISIS: AMBER ESTA SIN ALTERACION DEL ESTADO DE CONSCIENCIA. AFEBRIL, HIDRATADO, EUVOLEMICO. EUPNEICO, SO2 NORMAL SIN OXIGENOTERAPIA. CON GASTO CARDIACO Y PERFUSION TISULAR NORMALES. SIN ABDOMEN AGUDO. CON FUNCION RENAL CONSERVADA. SIN COAGULOPATIA. RESPUESTA INFLAMATORIA REGULADA. AMBER CURSA CON LESION GRAVE POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA, CON SIGNOS QUE HACEN SOSPECHAR LESION VASCULAR. EN ALTO RIESGO DE RABDOMIOLISIS TRAUMATICA Y DE FALLA RENAL SECUNDARIA. NO PRESENTA COMPROMISO NEUROLOGICO, RESPIRATORIO NI HEMODINAMICO. SE DEJA CON HIDRATACION CON CRISTALOIDE BALANCEADO, ANALGESIA MULTIMODAL Y ANTIBIOTICOTERAPIA EMPIRICA. LE EXPLICO A LA MADRE EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DEL NIÑO, RIESGOS Y PLAN DE MANEJO.
NOTA ADICIONAL: CIRUJANA VASCULAR REVISA LA ARTERIOGRAFIA DE LA PIERNA DERECHA CONCEPTUANDO QUE SE EVIDENCIA COMPROMISO DEL FLUJO DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA PERO QUE DICHA LESION NO ES REVASCULARIZABLE, NI TIENE INDICACION QUIRURGICA POR CIRUGIA VASCULAR.

*DIAGNOSTICOS:
TRAUMA GRAVE POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA.
RABDOMIOLISIS TRAUMATICA.
LESION VASCULAR DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA.
FRACTURA DIAFISIARIA DE TIBIA Y PERONE DERECHOS.

*PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
- CABECERA A 30°
- NADA POR VIA ORAL
- HARTMAN A 100 CC/H, IV.
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).
- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5).
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV.
- MORFINA 3 MG, C/4H, IV (SI EVA >4. MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE).
-OXIGENOTERAPIA A 1 L/MIN POR CANULA NASAL CONVENSIONAL.
- GLUCOMETRIAS CADA 6 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
- MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES
- CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- VALORACION POR ORTOPEDIA Y TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4

JOSE GERMAN NARVAEZ B. PEDIATRA INTENSIVISTA. RM 52305/2000 - 76319436

2026-03-08 18:06	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

CORRECCION DE NOMBRE.
LA MADRE INFORMA QUE EL NIÑO SE LLAMA AMBER JACDIEL RAMOS BRACHO.

2026-03-08 18:40	**PROFESIONAL:** marruino - MARIA CAMILA RUIZ NOGUERA	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

EVOLUCION DE FISIOTERAPIA
NOTA DE INGRESO A UCI
NN-NN (AMBER JACDIEL RAMOS BRACHO)

SE INGRESA AL CUBÍCULO SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y EL PREVIO LAVADO DE MANOS SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL. PACIENTE DE SEXO MASCULINO DE 8 AÑOS DE EDAD, EN CONTEXTO DE:

*ENFERMEDAD ACTUAL: EL NIÑO INGRESO AL SERVICION DE URGENCIAS EN COMPAÑÍA DE PERSONAL PARAMÉDICO Y DE SU MADRE, EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO. AL PARECER UN CARRO LE PASO POR ENCIMA DE LA PIERNA DERECHA GENERANDOLE TRAUMA GRAVE POR APLASTAMIENTO EN DICHA EXTREMIDAD. CON SOSPECHA DE COMPROMISO VASCULAR, EXPOSICION USCULAR Y OSEA. LIMITACION DE LOS ARCOS DE MOVILIDAD DOLOR INTENSO.
SIN ESTIGMAS DE TRAUMA A OTROS NIVELES. NIEGA TRAUMA CRANEOENCEFALICO, TORACICO Y ABDOMINAL.

DIAGNOSTICOS:
TRAUMA GRAVE POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA.
RABDOMIOLISIS TRAUMATICA.
LESION VASCULAR DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA.
FRACTURA DIAFISIARIA DE TIBIA Y PERONE DERECHOS.

A LA REVISIÓN POR SISTEMAS

*SISTEMA NEUROLÓGICO: SE ENCUENTRA PACIENTE EN POSICIÓN DECÚBITO SUPINO, PACIENTE SIN SEDOANALGESIA, CON UN ESTADO NEUROLÓGICO CON UNA PUNTUACIÓN DE 15/15 SEGÚN ESCALA GLASGOW, ORIENTADO EN TIEMPO, PERSONA, Y ESPACIO, COLABORADOR.
*SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR: SE ENCUENTRA HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE SIN REQUERIMIENTO DE VASOPRESOR, CON SIGNOS VITALES:
- FRECUENCIA CARDIACA 108 LATIDOS POR MINUTO
- TENSIÓN ARTERIAL 117/83 MILÍMETROS DE MERCURIO
- SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO 99%
- FRECUENCIA RESPIRATORIA 25 RESPIRACIONES POR MINUTO
SE ENCUENTRA CON UN PATRÓN VENTILATORIO COSTODIAFRAGMÁTICO, CON EXCURSIÓN TORÁCICA CONSERVADA. A LA AUSCULTACIÓN SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, SIN SOBREAGREGADOS PULMONARES. NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
PACIENTE CUENTA SIN SOPORTE DE OXÍGENO SUPLEMENTARIO, FIO2 DE 21%

*SISTEMA OSTEOMUSCULAR:
ARCOS DE MOVILIDAD ARTICULAR PASIVA Y ACTIVA CONSERVADA EN MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, FUERZA MUSCULAR GLOBAL CONSERVADA EN MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
DEFORMIDAD DE LA PIERNA DERECHA. GRAN HERIDA LONGITUDINAL PRETIBIAL POR APLASTAMIENTO CON ESTALLIDO DE PIEL Y EXPOSICION DE TEJIDO MUSCULAR, QUE COMPROMETE DESDE LA TUBEROSIDAD TIBIAL ANTERIOR HASTA LA ARTICULACION DEL TOBILLO DE LA PIERNA DERECHA. SIN SANGRADO ACTIVO.
FUERZA MUSCULAR EVALUADA CON MRC:
— ABDUCCIÓN DEL HOMBRO: 5/5 (DERECHO) 5/5 (IZQUIERDO)
— FLEXIÓN DEL CODO: 5/5 (DERECHO) 5/5 (IZQUIERDO)
— EXTENSIÓN DE LA MUÑECA: 5/5 (DERECHA) 5/5 (IZQUIERDA)
— FLEXIÓN DE LA CADERA: 5/5 (DERECHA) 5/5 (IZQUIERDA)
— EXTENSIÓN DE LA RODILLA: 3/5 (DERECHA) 5/5 (IZQUIERDA)
— DORSIFLEXIÓN DEL PIE: NE (DERECHO) 5/5 (IZQUIERDO)

OBJETIVOS
- PREVENIR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
- MANTENER OXÍMETRÍA >92%
- PROMOVER EJERCICIOS DE EXPANSIÓN PULMONAR
- REEDUCACIÓN DE MECÁNICA VENTILATORIA
- PROVEER FUNCIÓN MOTORA
- MANTENER RANGOS DE MOVILIDAD ARTICULAR GLOBAL
- EVITAR RETRACCIONES MUSCULARES
- MOVILIZACIÓN TEMPRANA

INTERVENCION
- MONITORÍA RESPIRARTORIA
- POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER CON CABECERA DE CAMA A 30°
- EJERCICIOS DE RE EXPANSIÓN TORÁCICA
- SE DEJA PACIENTE CON OXIGENOTERAPIA DADA POR CÁNULA NASAL SIMPLE, FIO2 24%, CON OXIMETRÍAS DE 99%-100%.

SE DEJA PACIENTE ESTABLE DENTRO DE SU CONDICIÓN CLÍNICA. SE DEJA CAMA A 30°, CON BARANDAS ARRIBA.

2026-03-08 19:16	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

DE ORDEN 202603080233
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 18:45

CPK TOTAL 321.0 U/L ELEVADA.
NITROGENO UREICO 13.0 mg/dl NORMAL
POTASIO 3.70 mmol/L NORMAL
SODIO 133.0 mmol/L HIPONATREMIA LEVE
CREATININA SERICA 0.50 mg/dl NORMAL

INR 1.19
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 24.9 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 4.07 X10*6/mm³
MCV 81.6 um3
MCH 28.5 pg
MCHC 34.9 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 38.7 um3
RDW CV 12.8 %
MPV 9.6 um3
NEUTROFILOS Abs 11.21
LINFOCITOS Abs 4.95
MONOCITOS Abs 1.02
EOSINOFILOS Abs 0.88

BASOFILOS Abs 0.05
NEUTROFILOS % 61.4 %
LINFOCITOS % 27.1 %
MONOCITOS % 5.6 %
EOSINOFILOS % 4.8 %
BASOFILOS % 0.3 %
HEMATOCRITO 33.2 %
HEMOGLOBINA 11.6 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 18.26 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 428 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOCITOSIS CON NEUTROFILIA, ANEMIA LEVE EN LIMITE DE MODERADA, NORMOCITICA AGUDA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL DE MOMENTO.

2026-03-08 19:17	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE IMAGENES

RADIOGRAFIA DE TOBILLO DERECHO 2026-03-08 17:01*****PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL SE EVIDENCIA FRACTURA DIAFISIARIA DISTAL DE TIBIA Y PERONE, CON APARENTE COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS ADYACENTE.

RADIOGRAFIA DE PIERNA DERECHA 2026-03-08 17:03*****PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL SE EVIDENCIA FRACTURA DIAFISIARIA DISTAL DE TIBIA Y PERONE, CON APARENTE COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS ADYACENTE.

ANGIOTAC DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO 2026-03-08 17:26**********PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL NO SE EVIDENCIA COMPROMISO VASCULAR APARENTE NI EXTRAVASACION DE MEDIO DE CONTRASTE.

ATENTOS DE LLAMADO DE QUIROFANO.

2026-03-08 21:57	**PROFESIONAL:** juapraoj - JUAN SEBASTIAN PRADO OJEDA	**ESPECIALIDAD:** ORTOPEDIA PEDIATRICA

ORTOPEDIA INFANTIL
VALORACION COMO URGENCIA VITAL
TRAUMA POR APLASTAMIENTO DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO
CUADRO DE 4 HORAS DE EVOLCUION DE TRAUMA POR APLASTAMIENTO DE PIERNA DERECHA POR ACCIDENTE DE TRANSITO CON POSTERIOR DEGLOVING CIRCUNFERENCIAL SANGRADO EXPOSICION OSTEOIOTENDINOSA EN PIERNA DERECHA POR LO QUE CONSUTLA

EXAMEN FISICO
DEGLOVING CIRCUNFERENCIAL DE APROX 80% DE LA PIERNA DERECHA CON COMPROMISO DE COMPARTIMIENTO ANTERIOR, ALTERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL CON DEFECTO CRITICO DE COBERTURA DE APROX 15CM, PUSO PEDIO TIBIAL POSTEIROR Y TIBIAL ANTERIOR PRESENTE. LLENADO CAPILAR MENOR A 2SEG. INCAPACIDAD PARA DORIFLEXION Y PLANTIFLEXION (DOLOR SHOCK)

RX
FX DIAFISARIA DE TIBIA Y PERONE DERECHO

PACIENTE CON FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PEROJE DERECHO CON LESION SEVERA DE TEJIDOS BLANDOS CON COMPROMISO DE COMPARTIMIETNOS DESCRITOS, SE EXPLICA A FAMILIAR RIESGO DE COMPLICACONES SEVERAS COMO PERDIDA DE LA EXTREMDIAD SE REALIZARA CIRUGIA DE CONTROL DE DAÑOS PARA FIJACION DE FRACTURA ABIERTA Y REPARACION DE LESIONES LOCALES. SE EXPLICA.

2026-03-08 22:17	**PROFESIONAL:** juapraoj - JUAN SEBASTIAN PRADO OJEDA	**ESPECIALIDAD:** ORTOPEDIA PEDIATRICA

NOTA POP
POP (8/03/26) LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONE DERECHO
POP (8/03/26) DESBIRDMAIENTO CON REPARACION MIOTENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL DEFECTO DE COBERTURA CRITICO EN PIERNA DERECHA CON COLOCACION DE SISTEMA DE PRESION SUB ATMOSFERICA

MID PRESNEICA DE YESO SUROPEDICO EN POSICION SISTEMA VAC FUNCIONAL

PACIENTE CON LESION CRITICA DE PIERNA DERECHA POR APLASTAMIENTO CON DEGLOVING CIRCUNFERNECIAL DEL 80% CONTAMINACION MASIVA, MACERACION DE TEJIDOS Y VIENTRESS MSUCULARES SE HACE CONTROL DE DAÑO Y SE REPARAN LESIONES DESCRITAS. PACIENTE REQUIERE NUEVO LAVADO EN 4-5 DIAS (JUEVES O VIERNES) PARA CAMBIO DE VAC VALIDAR ESTADO DE TEJIDOS BLANDOS. LAS FRACTURAS YA SE ENCUENTRAN FIJADAS (PERONE DEFINITIVO Y TIBIA POR ESTABLIDAD MANEJO CONSERVADOR CON YESO) YA PUESTO
EL OBJETIVO PRINCIAL ES QUE NO SE INFECTE EL DEGLOVING Y LA VIABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS. EN CASO DE EVOLUCIONR SATISFACTORIAMENTE Y SIN INFECCION REQUERIRA POSTEIROR COBERTURA POR CX PLASTICA. SE EXPLICA A MADRE.

TRASLADO A UCI
SS RX POP DE PIERNA DERECHA
NUEVO TIEMPO 1X EN 4-5 DIAS

2026-03-08 22:44	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

*** NOTA RETROSPECTIVA 20+00 HORAS**

PACIENTE TRASLADO A SALA DE CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL PARA LAVADO + DECRIBIMIENTO DE PIERNA IZQUIERDA
CON LOS SIGUIENTE SIGNOS VITALES: TA: 136/73 MMHG, FC: 99 LPM, FR:22 RPM, SO2: 100% SIN SOPORTE DE OXIGENO. NO SOPORTE VASOPRESOR, NI INFUSION DE SEDANTES.
TRASLADO SIN COMPLICACIONES

2026-03-08 22:56	**PROFESIONAL:** hanlisbo - HANSEL STEVEN LIS BOLAÑOS	**ESPECIALIDAD:** ANESTESIOLOGIA

NOTA PREANESTESICA:
PROCEDIMIENTO LAVADO DEBRIDAMIENTO + OSTEOSINTESIS DE PIERNA DERECHA
ANESTESIA GENERAL

NOMBRE: NN-NN (AMBER JACDIEL BRACHO MEDOZA)
EDAD: 8 AÑOS

IDENTIFICACION: MS-VEN000316
FECHA DE NACIMIENTO: 08/03/2018
ORIGEN: VENEZUELA.
PROCEDENCIA: CALI - VALLE
ENTIDADA: SOAT
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 08/03/2026
FECHA DE INGRESO A UCIP: 08/03/2026

*MOTIVO DE CONSULTA: ACCIDENTE DE TRANSITO.

*ENFERMEDAD ACTUAL: EL NIÑO INGRESO AL SERVICION DE URGENCIAS EN COMPAÑÍA DE PERSONAL PARAMÉDICO Y DE SU MADRE, EN CONTEXTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO. AL PARECER UN CARRO LE PASO POR ENCIMA DE LA PIERNA DERECHA GENERANDOLE TRAUMA GRAVE POR APLASTAMIENTO EN DICHA EXTREMIDAD. CON SOSPECHA DE COMPROMISO VASCULAR, EXPOSICION USCULAR Y OSEA. LIMITACION DE LOS ARCOS DE MOVILIDAD DOLOR INTENSO.

SIN ESTIGMAS DE TRAUMA A OTROS NIVELES. NIEGA TRAUMA CRANEOENCEFALICO, TORACICO Y ABDOMINAL.

*REVISION POR SISTEMAS: PREVIAMENTE SANO.

*ANTECEDENTES.
-PATOLOGICOS: NINGUNO CONOCIDO.
-QUIRURGICOS: NINGUNO
-ALERGICOS: NINGUNO CONOCIDO
-VACUNAS: SIN INFORMACION OBJETIVA
-EPIDEMIOLOGICOS: SIN NOXA DE CONTAGIO
-FAMILIARES: SIN INFORMACION

*CONCILIACION MEDICAMENTOSA: NINGUNA.

*OBJETIVO:
FC: 115/MIN. TA: 132/90/100. FR: 25/MIN. SO2: 98% CON FIO2 DEL 21%. T: 36 °C. GLUCOMETRIA: 158 MG/DL.
NEUROLOGICO: ALERTA, PUPILAS A 3 MM REACTIVAS, MOVIMIENTOS OCULARES NORMALES. SIN SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA NI FOCALIZACION.
ORL: SIN ALETEO NASAL, QUEJIDO NI ESTRIDOR. BOCA HUMEDA.
CUELLO: LLENADO YUGULAR NORMAL. SI MASAS. MOVIL E INDOLORO.
TORAX: TAQUIPNEICO, EXPANSIBILIDAD SIMETRICA, SIN RETRACCIONES.
PULMONES: MURMULLO VESICULAR NORMAL. SIN AGREGADOS.
CARDIOVASCULAR: TAQUICARDICO, EN SINUSAL, SIN SOPLOS, PULSOS NORMALES, LL. CAPILAR <2S, HIPERTENSO, EUTERMICO.
ABDOMEN: PERISTALTISMO NORMAL, BLANDO, INDOLORO. SIN DISTENSION, ASCITIS, MASAS NI MEGALIAS.
RENAL: HIDRATADO, EUVOLEMICO, SIN EDEMA. GASTO URINARIO NO CUANTIFICADO.
HEMATOLOGICO: SIN SANGRADO ACTIVO NI SIGNOS DE COAGULOPATIA.
INFECCIOSO: AFEBRIL, RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA REGULADA.
OSTEOMUSCULAR: DEFORMIDAD DE LA PIERNA DERECHA. GRAN HERIDA LONGITUDINAL PRETIBIAL POR APLASTAMIENTO CON ESTALLIDO DE PIEL Y EXPOSICION DE TEJIDO MUSCULAR, QUE COMPROMETE DESDE LA TUBEROSIDAD TIBIAL ANTERIOR HASTA LA ARTICULACION DEL TOBILLO DE LA PIERNA DERECHA. SIN SANGRADO ACTIVO. COLORACION VIOLACEA DEL DORSO DEL PIE DERECHO CON LLENADO CAPILAR EN 3 S.

*ANALISIS: AMBER ESTA SIN ALTERACION DEL ESTADO DE CONSCIENCIA. AFEBRIL, HIDRATADO, EUVOLEMICO. EUPNEICO, SO2 NORMAL SIN OXIGENOTERAPIA. CON GASTO CARDIACO Y PERFUSION TISULAR NORMALES. SIN ABDOMEN AGUDO. CON FUNCION RENAL CONSERVADA. SIN COAGULOPATIA. RESPUESTA INFLAMATORIA REGULADA. AMBER CURSA CON LESION GRAVE POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA, CON SIGNOS QUE HACEN SOSPECHAR LESION VASCULAR. EN ALTO RIESGO DE RABDOMIOLISIS TRAUMATICA Y DE FALLA RENAL SECUNDARIA. NO PRESENTA COMPROMISO NEUROLOGICO, RESPIRATORIO NI HEMODINAMICO. SE DEJA CON HIDRATACION CON CRISTALOIDE BALANCEADO, ANALGESIA MULTIMODAL Y ANTIBIOTICOTERAPIA EMPIRICA. LE EXPLICO A LA MADRE EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DEL NIÑO, RIESGOS Y PLAN DE MANEJO.
NOTA ADICIONAL: CIRUJANA VASCULAR REVISA LA ARTERIOGRAFIA DE LA PIERNA DERECHA CONCEPTUANDO QUE SE EVIDENCIA COMPROMISO DEL FLUJO DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA PERO QUE DICHA LESION NO ES REVASCULARIZABLE, NI TIENE INDICACION QUIRURGICA POR CIRUGIA VASCULAR.

*DIAGNOSTICOS:
TRAUMA GRAVE POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA.
RABDOMIOLISIS TRAUMATICA.
LESION VASCULAR DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA.
FRACTURA DIAFISIARIA DE TIBIA Y PERONE DERECHOS.

PACIENTE CON AYUNO COMPLETO MAYOR A 8 HORAS
SE EXPLICA TÉCNICA ANESTÉSICA Y SE ACLARAN DUDAS
SE FIRMAN CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
VERIFICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO CON EQUIPO QUIRÚRGICO
ASA III CF I/IV RQ INTERMEDIO - BAJO
LABORATORIOS DE BAJO RIESGO
NO PREDICTORES DE VÍA AÉREA DIFÍCIL
MP I APO > 4 CM DTM > 6 CM DEM > 12 CM
SE PASA A SALAS DE CIRUGÍA

2026-03-08 23:35	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

*** REINGRESO DE SALA DE CIRUGIA **
NN
8 AÑOS

PACIENTE POP (8/03/26) LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONE DERECHO Y POP (8/03/26) DESBORDAMIENTO CON REPARACIÓN TENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL

INGRESA DE SALA DE CIRUGIA, SOMNOLIENTO SECUNDARIO A ANESTESIA, CON LOS SIGUIENTES SIGNOS VITALES:
TA: 129/64 MMHG, FC: 102 LPM, DR: 18%, SO2: 98% MASCARA SIMPLE FIO2: 28%
INGRESA TAQUICARDICO , LLENADO CAPILAR 2-3 SEGUNDIOS, NORMOTENSO, SE INDICO TOMA DE GASES ARTERIALES Y HEMOGRAMA PARA DETERMINAR CRITERIO DE TRANSFUSION.
CONTINUA MANEJO INGREGAL EN UCI.

2026-03-09 00:19	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS- PEDIATRIA - NOCHE
NOTA REALIZADA A LAS 22+00 HORAS, SE SUBE A ESTA HORA POR CONGESTION DEL SERVICIO
DR. DIANA DONNEYS (MD ESPECIALISTA) -SEBASTIAN MONTES (MD ASISTENCIAL)
NOMBRE: NN-NN (AMBER JACDIEL BRACHO MEDOZA)
EDAD: 8 AÑOS
IDENTIFICACION: MS-VEN000316
FECHA DE NACIMIENTO: 08/03/2018
ORIGEN: VENEZUELA.
PROCEDENCIA: CALI - VALLE
ENTIDADA: SOAT
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 08/03/2026
FECHA DE INGRESO A UCIP: 08/03/2026

*DIAGNOSTICOS:
TRAUMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA.
LESIÓN VASCULAR DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA.
POP (8/03/26) LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONE DERECHO
POP (8/03/26) DESBORDAMIENTO CON REPARACIÓN TENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL
DEFECTO DE COBERTURA CRITICO EN PIERNA DERECHA CON COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN SUB ATMOSFÉRICA

*CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA, RESPIRATORIA, NEUROLÓGICA CONTINUA NO INVASIVA
.- POP DE CIRUGÍA MAYOR
.- ALTO RIESGO DE FENÓMENOS TROMBÓTICOS

*SOPORTES:
-NO

*INFUSIONES:
- NO

EVENTOS
-POP INMEDIATO DE LAVADO + DESBRIDAMIENTO DE PIERNA DERECHO
-SISTEMA DE VAC FUNCIONAL
-SOMNOLIENTO SECUNDARIO A CIRUGÍA

EXAMEN FÍSICO:
PESO 35 KG
TALLA 124

VALORACIÓN NUTRICIONAL
PESO: 30 KG (P87, 1,10DE) (OMS 2006/2007)
TALLA: 124 CM (P28, -0,58DE) (OMS 2006/2007)
IMC: 19,51 KG/M2 (P97, 1,94DE) (OMS 2006/2007)

SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 140/75 MMHG (TAM 77 MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 93 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA 17 RXM
SATURACIÓN DE O2 98 % FiO2 21%
TEMPERATURA 36.3 °C AFEBRIL DESDE EL INGRESO

BALANCE HÍDRICO EN 3 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 180 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 700 CC
GU: EN CUANTIFICACIÓN

- HEMODINÁMICO: SIN SOPORTE VASOACTIVO, POSTERIOR A CIRUGÍA TAQUICARDIA LLENADO CAPILAR DE 3 SEGUNDOS, TENSIONES ARTERIALES EN METAS, L PULSOS SIMÉTRICOS REGULARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS
- RESPIRATORIO: TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS NO SOBREAGREGADOS.
- GASTROINTESTINAL: ABDOMEN NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN LLANTO A LA PALPACIÓN, NO IRRITACIÓN PERITONEAL.
- RENAL: MICCION ESPONTANEA, ORINA CLARA, NO EDEMAS.
- METABÓLICO: SIN NADA VIA ORAL , NO EMESIS, GLUCOMETRIA 158 MG/DL
- HEMATOLÓGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS
- INFECCIOSO: NO PICOS FEBRILES MANEJO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA /SULBACTAM
- NEUROLÓGICO: GLASGOW 15/15, PUPILAS ISOCORICAS Y REACTIVAS, ALERTA, ACTIVO, REACTIVO, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE

ANTIBIÓTICO:
AMPICILINA /SULBACTAM 1.8 GR CADA 6 HORAS FI: 08/03/2026

ANALISIS

PACIENTE DE 8 AÑOS, CON POLITRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE PIERNA , CON LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
*HEMODINÁMICO:TAQUICÁRDICO POSTERIOR A PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO , CIFRAS TENSIONES EN METAS, LLENADO CAPILAR DE 3 SEGUNDOS, SE INIDO TOMA DE GASES VENOSOS Y HEMOGRAMA PARA DEFINIR CRITERIO DE TRANSFUSION.
*RESPIRATORIO: AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS NO RUIDOS SOBREAGREGADOS, SAFI: 466 SIN TRASTORNO DE OXIGENACIÓN.
*METABÓLICO: SIN NADA VIA ORAL, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL
*OSTEOMUSCULAR: TRAUMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA.
LESIÓN VASCULAR DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA., POP (8/03/26) LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONÉ DERECHO, POP (8/03/26) DESBORDAMIENTO CON REPARACIÓN TENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL DEFECTO DE COBERTURA CRITICO EN PIERNA DERECHA CON COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN SUB ATMOSFÉRICA. PACIENTE CON SISTEMA VAC FUNCIONAL , CON DOLOR MODULADO . DEBE CONTINUAR MANEJO ANTIBIÓTICO ACTUAL.
*NEUROLÓGICO:SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO , NO SIGNOS DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA.
PACIENTE CIENTE EN CONDICIÓN CRITICA, REQUIERE MONITOREO NEUROLOGICO, HEMODINAMICO Y RESPIRATORIO. SE EXPLICA A LA MADRE QUIEN ENITENDE Y ACEPTA.

*PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
- CABECERA A 30°
- NADA POR VIA ORAL
- BOLO DE SSN 300 CC (YA ADMINISTRADO), LEV HARTMAN 80CC/HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).
- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5).
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV.
- MORFINA 1.5 MG, C/4H, IV (SI EVA >4. MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE).
- GLUCOMETRIAS CADA 6 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
- MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES
- CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS

SE SOLICITA
HEMOGRAMA , GASES VENOSOS

EN PROCESO
PROCEDIMIENTO POR ORTOPEDIA
VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4

GRACIAS!

2026-03-09 00:24	**PROFESIONAL:** yurherri - YURY NATHALYA HERNANDEZ RINCON	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

NOTA FISIOTERAPIA MADRUGADA
PACIENTE CON MEJORIA EN ESTADO DE CONCIENCIA, OXIMETRIAS EN METAS, CON SOPORTE DE OXIGENO DE BAJO FLUJO FIO2: 28%, SE DESMONTA PROGRESIVAMENTE A AIRE AMBIENTE FIO2: 21%, TOLERANDO SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS, SE CONTINUA VIGILANICA RESPRIATORIA.

2026-03-09 01:28	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

DE ORDEN 202603080245
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 20:28
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

DE ORDEN 202603080233
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 18:45

CPK TOTAL 321.0 U/L ELEVADA.
NITROGENO UREICO 13.0 mg/dl NORMAL
POTASIO 3.70 mmol/L NORMAL
SODIO 133.0 mmol/L HIPONATREMIA LEVE
CREATININA SERICA 0.50 mg/dl NORMAL

INR 1.19
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 24.9 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 4.07 X10*6/mm³
MCV 81.6 um3
MCH 28.5 pg

MCHC 34.9 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 38.7 um3
RDW CV 12.8 %
MPV 9.6 um3
NEUTROFILOS Abs 11.21
LINFOCITOS Abs 4.95
MONOCITOS Abs 1.02
EOSINOFILOS Abs 0.88
BASOFILOS Abs 0.05
NEUTROFILOS % 61.4 %
LINFOCITOS % 27.1 %
MONOCITOS % 5.6 %
EOSINOFILOS % 4.8 %
BASOFILOS % 0.3 %
HEMATOCRITO 33.2 %
HEMOGLOBINA 11.6 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 18.26 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 428 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOCITOSIS CON NEUTROFILIA, ANEMIA LEVE EN LIMITE DE MODERADA, NORMOCITICA AGUDA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL DE MOMENTO.

2026-03-09 01:33	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE IMAGENES

RADIOGRAFIA DE TOBILLO DERECHO 2026-03-08 17:01*****PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL SE EVIDENCIA FRACTURA DIAFISIARIA DISTAL DE TIBIA Y PERONE, CON APARENTE COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS ADYACENTE.

RADIOGRAFIA DE PIERNA DERECHA 2026-03-08 17:03*****PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL SE EVIDENCIA FRACTURA DIAFISIARIA DISTAL DE TIBIA Y PERONE, CON APARENTE COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS ADYACENTE.

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA
ANGIOTOMOGRAFÍA DE PIERNA DERECHA
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde el mesogastrio hasta los tobillos, previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa. Se realiza adquisición en fase de contraste arteria femoral con reconstrucciones multiplanares y volumétricas 3D, evidenciando:
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Adecuada permeabilidad sin áreas de estenosis ni trombosis a nivel de las arterias femoral común, femoral superficial, femoral profunda , poplítea, tronco tibio-peroneo , tibial posterior , peronera y tibial anterior en todo su recorrido.
Relaciones articulares conservadas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En especial no se identifican lesiones sugestivas de fistula AV ni pseudoaneurismas.
Relaciones articulares conservadas.
Fracturas que comprometen la diáfisis medial y distal de la tibia y el peroné con angulación de fragmentos óseos del peroné.
Áreas de edema y enfisema en los tejidos blandos.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Adecuada permeabilidad sin áreas de estenosis ni trombosis a nivel de la arteria femoral común, femoral superficial, femoral profunda, poplítea, tronco tibio-peronero, tibial posterior, peronera y tibial anterior en todo su recorrido.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En especial no se identifican lesiones sugestivas de fístula AV ni pseudoaneurismas.
Relaciones articulares conservadas.
OPINIÓN
ANGIOTOMOGRAFÍA DE MIEMBROS INFERIORES DENTRO DE LÍMITES NORMALES SIN IMÁGENES DE EXTRAVASACIÓN DEL MEDIO DE CONTRASTE QUE SUGERAN LESIÓN VASCULAR.
FRACTURAS DESCRITAS EN LA PIERNA DERECHA ASOCIADAS A CAMBIOS INFLAMATORIOS Y ÁREAS DE ENFISEMA EN LOS TEJIDOS BLANDOS.
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 23:35

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA
ANGIOTOMOGRAFÍA DE PIERNA DERECHA
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 23:35

2026-03-09 05:26	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

DE ORDEN 202603090042
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:38
GASES VENOSOS PERIFERICO
pH 7.232
PCO2 48.7 mmHg
pO2 26.4
HCO3act 20.0 mmol/L
BE(B) -7.3 mmol/L
SO2 41.5 %
ACIDEMIA METABOLICA NO SEVERA, DEFICIT DE BASE. EXTRACCION DE OXIGENO NO VALORABLE POR NO SER GASES CENTRALES.

DE ORDEN 202603090040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:37

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.60 X10*6/mm³
MCV 82.0 um3
MCH 28.3 pg
MCHC 34.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.4 %
RDW SD 39.3 um3
RDW CV 13.0 %
MPV 8.8 um3
NEUTROFILOS Abs 8.92
LINFOCITOS Abs 1.00
MONOCITOS Abs 0.35
EOSINOFILOS Abs 0.02
BASOFILOS Abs 0.02
NEUTROFILOS % 85.5 %
LINFOCITOS % 9.6 %
MONOCITOS % 3.4 %
EOSINOFILOS % 0.2 %
BASOFILOS % 0.2 %
HEMATOCRITO 29.5 %
HEMOGLOBINA 10.2 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.42 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 347 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, ANEMIA MODERADA, LEUCOS EN RANGOS DE NORMALIDAD CON DESVIACION A LA IZQUIERDA.

DE ORDEN 202603080245
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 20:28
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

DE ORDEN 202603080233
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 18:45

CPK TOTAL 321.0 U/L ELEVADA.
NITROGENO UREICO 13.0 mg/dl NORMAL
POTASIO 3.70 mmol/L NORMAL
SODIO 133.0 mmol/L HIPONATREMIA LEVE
CREATININA SERICA 0.50 mg/dl NORMAL

INR 1.19
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 24.9 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 4.07 X10*6/mm³
MCV 81.6 um3
MCH 28.5 pg
MCHC 34.9 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 38.7 um3
RDW CV 12.8 %
MPV 9.6 um3
NEUTROFILOS Abs 11.21
LINFOCITOS Abs 4.95
MONOCITOS Abs 1.02
EOSINOFILOS Abs 0.88
BASOFILOS Abs 0.05
NEUTROFILOS % 61.4 %
LINFOCITOS % 27.1 %
MONOCITOS % 5.6 %
EOSINOFILOS % 4.8 %
BASOFILOS % 0.3 %
HEMATOCRITO 33.2 %

HEMOGLOBINA 11.6 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 18.26 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 428 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOCITOSIS CON NEUTROFILIA, ANEMIA LEVE EN LIMITE DE MODERADA, NORMOCITICA AGUDA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL DE MOMENTO.

2026-03-09 06:04	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE IMAGENES

RADIOGRAFIA DE PIERNA DERECHA CONTROL POP 2026-03-09 05:46 **********PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL SE EVIDENCIA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN PERONE CON ADECUADA REDUCCION DE FRACTURA, FRACTURA DE TIBIA ALINEADA, PRESENCIA DE FERULA SUROPEDICA.

RADIOGRAFIA DE TOBILLO DERECHO 2026-03-08 17:01**********PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL SE EVIDENCIA FRACTURA DIAFISIARIA DISTAL DE TIBIA Y PERONE, CON APARENTE COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS ADYACENTE.

RADIOGRAFIA DE PIERNA DERECHA 2026-03-08 17:03**********PENDIENTE REPORTE OFICIAL, COMO OPINION PERSONAL SE EVIDENCIA FRACTURA DIAFISIARIA DISTAL DE TIBIA Y PERONE, CON APARENTE COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS ADYACENTE.

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA
ANGIOTOMOGRAFÍA DE PIERNA DERECHA
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde el mesogastrio hasta los tobillos, previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa. Se realiza adquisición en fase de contraste arteria femoral con reconstrucciones multiplanares y volumétricas 3D, evidenciando:
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Adecuada permeabilidad sin áreas de estenosis ni trombosis a nivel de las arterias femoral común, femoral superficial, femoral profunda , poplítea, tronco tibio-peroneo , tibial posterior , peronera y tibial anterior en todo su recorrido.
Relaciones articulares conservadas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En especial no se identifican lesiones sugestivas de fistula AV ni pseudoaneurismas.
Relaciones articulares conservadas.
Fracturas que comprometen la diáfisis medial y distal de la tibia y el peroné con angulación de fragmentos óseos del peroné.
Áreas de edema y enfisema en los tejidos blandos.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Adecuada permeabilidad sin áreas de estenosis ni trombosis a nivel de la arteria femoral común, femoral superficial, femoral profunda, poplítea, tronco tibio-peronero, tibial posterior, peronera y tibial anterior en todo su recorrido.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En especial no se identifican lesiones sugestivas de fístula AV ni pseudoaneurismas.
Relaciones articulares conservadas.
OPINIÓN
ANGIOTOMOGRAFÍA DE MIEMBROS INFERIORES DENTRO DE LÍMITES NORMALES SIN IMÁGENES DE EXTRAVASACIÓN DEL MEDIO DE CONTRASTE QUE SUGERAN LESIÓN VASCULAR.
FRACTURAS DESCRITAS EN LA PIERNA DERECHA ASOCIADAS A CAMBIOS INFLAMATORIOS Y ÁREAS DE ENFISEMA EN LOS TEJIDOS BLANDOS.
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 23:35

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA
ANGIOTOMOGRAFÍA DE PIERNA DERECHA
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 23:35

2026-03-09 14:09	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE IMAGENES

.- ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE PIERNA DERECHA
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-09
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA

TÉCNICA:
Proyecciones: AP y lateral pierna derecha.
HALLAZGOS:

Fractura de la diáfisis distal de la fíbula con alineación y fijación con clavo.
Férula de yeso posterior y plantar que limita algo la visualización de las estructuras.
Dispositivo de manejo de heridas en tejidos blandos anteriores, con edema en tejidos blandos.
Fractura de la diáfisis de la tibia en la unión del tercio medio y distal sin desplazamiento significativo.
Alteración en la trabeculación de la patela, sugiriendo estigmas de trauma antiguo. Correlacionar con antecedentes.
Congruencia articular respetada.
No se observan lesiones líticas o blásticas que sugieran neoplasias.

Informe firmado electrónicamente por:
César Augusto Mayorga Hurtado
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 10013375
Fecha y hora de firma: 09-03-2026 12:43

.- ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE PIERNA DERECHA
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA

DLP 0.516 mGy.cm.
TÉCNICA:
Se obtienen proyecciones AP y lateral en las que se observa:
HALLAZGOS:
Fracturas conminuta diafisarias distales de tibia y fibula con fragmentos angulados en sentido lateral.
Los núcleos de crecimiento de aspecto habitual.
Las relaciones articulares son congruentes.
Edema y enfisema de los tejidos blandos.
Informe firmado electrónicamente por:

SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 09-03-2026 12:12

.- ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TOBILLO DERECHO
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA

DLP 0.52 mGy.cm
TÉCNICA:
Proyecciones AP y lateral, observando:
HALLAZGOS:
Fractura angulada del tercio distal de la diáfisis del perone.
Fractura angulada del tercio distal de la diáfisis de la tibia.
No compromete la parte más distal, ni la metáfisis ni la epífisis distal.
Los núcleos epifisarios de crecimiento presente de aspecto habitual.
Edema de los tejidos blandos

Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 09-03-2026 12:12

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA
ANGIOTOMOGRAFÍA DE PIERNA DERECHA
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde el mesogastrio hasta los tobillos, previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa. Se realiza adquisición en fase de contraste arteria femoral con reconstrucciones multiplanares y volumétricas 3D, evidenciando:
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Adecuada permeabilidad sin áreas de estenosis ni trombosis a nivel de las arterias femoral común, femoral superficial, femoral profunda , poplítea, tronco tibio-peroneo , tibial posterior , peronera y tibial anterior en todo su recorrido.
Relaciones articulares conservadas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En especial no se identifican lesiones sugestivas de fistula AV ni pseudoaneurismas.
Relaciones articulares conservadas.
Fracturas que comprometen la diáfisis medial y distal de la tibia y el peroné con angulación de fragmentos óseos del peroné.
Áreas de edema y enfisema en los tejidos blandos.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Adecuada permeabilidad sin áreas de estenosis ni trombosis a nivel de la arteria femoral común, femoral superficial, femoral profunda, poplítea, tronco tibio-peronero, tibial posterior, peronera y tibial anterior en todo su recorrido.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.

En especial no se identifican lesiones sugestivas de fístula AV ni pseudoaneurismas.
Relaciones articulares conservadas.
OPINIÓN
ANGIOTOMOGRAFÍA DE MIEMBROS INFERIORES DENTRO DE LÍMITES NORMALES SIN IMÁGENES DE EXTRAVASACIÓN DEL MEDIO DE CONTRASTE QUE SUGERAN LESIÓN VASCULAR.
FRACTURAS DESCRITAS EN LA PIERNA DERECHA ASOCIADAS A CAMBIOS INFLAMATORIOS Y ÁREAS DE ENFISEMA EN LOS TEJIDOS BLANDOS.
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 23:35

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: NN NN
DOCUMENTO: MS VEN000316 EDAD: 8 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO SA
ANGIOTOMOGRAFÍA DE PIERNA DERECHA
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 23:35

2026-03-10 10:02	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIO- PEDIATRIA - DIA -
DRA. ANNY QUIÑONES (MD ESPECIALISITA) - FRANCISCO QUINTERO P (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: NN-NN (AMBEREEM JACDIEL RAMOS BRACHO)
EDAD: 8 AÑOS
IDENTIFICACION: MS-VEN000316
FECHA DE NACIMIENTO: 08/03/2018
ORIGEN: VENEZUELA.
PROCEDENCIA: CALI - VALLE
ENTIDADA: SOAT
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 08/03/2026
FECHA DE INGRESO A UCIP: 08/03/2026

*DIAGNOSTICOS:
1.- TRAUMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA.
2.- LESIÓN VASCULAR DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA.
– POP (8/03/26) LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONE DERECHO
– POP (8/03/26) DESBORDAMIENTO CON REPARACIÓN TENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL DEFECTO DE COBERTURA CRITICO EN PIERNA DERECHA CON COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN SUB ATMOSFÉRICA

*CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA, RESPIRATORIA, NEUROLÓGICA CONTINUA NO INVASIVA
.- POP DE CIRUGÍA MAYOR
.- ALTO RIESGO DE FENÓMENOS TROMBÓTICOS
.- MANEJO DE DOLOR

*INVASIONES
.- CATETER PERIFERICO MSD - 08/03/2026

*SOPORTES:
-NO

*INFUSIONES:
- NO

*EVENTOS
-POP DE LAVADO + DESBRIDAMIENTO DE PIERNA DERECHO
-SISTEMA DE VAC FUNCIONAL
-DOLOR MODULADO

* SUBJETIVO: PACIENTE EN COMPAÑIA DE SU MADRE QUIEN REFIERE QUE PASA BUENA NOCHE , LOGRA ADECUADA CONCILIACION DE SUEÑO, TOLERANDO LA VIA ORAL.

* OBJETIVO: PACIENTE EN CAMA CON BUENA INTERACCION CON EL MEDIO, DE MOMENTO SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, SIN DEFICIT NEUROVASCULAR DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO

* EXAMEN FÍSICO:
SE VALORA A PACIENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD

PESO 35 KG
TALLA 124 CM

VALORACIÓN NUTRICIONAL
PESO: 30 KG (P87, 1,10DE) (OMS 2006/2007)
TALLA: 124 CM (P28, -0,58DE) (OMS 2006/2007)
IMC: 19,51 KG/M2 (P97, 1,94DE) (OMS 2006/2007)

SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 114/57 MMHG (TAM 76 MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 120 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA 19 RXM
SATURACIÓN DE O2 97 % FiO2 21%
TEMPERATURA 36.3 °C AFEBRIL DESDE EL INGRESO

BALANCE HÍDRICO EN 24 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 2163 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 1520 CC
BALANCE DEL DIA 643+
BALANCE ACUMULADO: 253+
GU: 2.1 CC/KG/HR

METABOLICO: TOLERANDO VIA ORAL - GLUCOMETRIAS: 105 - 94 MG/DL - NO REALIZA DEPOSICIONES EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.

NORMOCONFIGURADO, OJOS SIMETRICOS PUPILS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, CONJUNTIVAS ROSADAS, ESCLERAS ANICTERICAS
ORL MUCOSAS HUMEDAS ROSADAS
CUELLO SIMETRICO NO ADENOPATIAS.
HEMODINAMICO RSCS RITMICOS NO AUSCULTO SOPLOS, PULSO CENTRAL Y PERIFERICO BUEN TONO LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS.
RESPIRATORIO: TÓRAX SIMÉTRICO, NO TIRAJES, CAMPOS PULMONARES VENTILADOS SIN AGREGADOS PULMONARES SIN SOPORTE DE OXIGENO.
GASTROINTESTINAL: ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE NO IMPRESIONA DOLOR A LA PALPACIÓN NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL NO MEGALIAS.
RENAL: MICCION ESPONTANEA, SIN ALTERACIONES, NO EDEMAS.
EXTREMIDADES: ANIVEL DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO INMOVILIZADO CON FERULA DE YESO, LLENADO CAPILAR DE LOS DEDOS DEL PIE Y PERFUSION DISTAL CONSERVADA. SISTEMA VAC FUNCIONAL CON ESCASO PRODUCIDO.
METABÓLICO: TOLERANDO VIA ORAL , NO EMESIS, GLUCOMETRIA 158 - 129 - 164 MG/DL, NO REALIZA DEPOSICIONES .
HEMATOLÓGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS.
INFECCIOSO: SIN DISTERMIAS, CONTINUA TERAPIA ANTIMICROBIANA AMPICILINA /SULBACTAM.
NEUROLÓGICO: GLASGOW 15/15, ORIENTADA EN TIEMPO Y ESPACIO. SIN CRISIS.

* ANTIBIÓTICO:
.- AMPICILINA /SULBACTAM 1.8 GR CADA 6 HORAS FI: 08/03/2026

ANALISIS

AMBER ESCOLAR DE 8 AÑOS, HOSPITALIZADA EN LA UNIDAD POR ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CARGA CINÉTICA CON POLITRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE PIERNA DERECHA CURSA POP DE LAVADO DESBRIDAMIENTO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. A LA VALORACIÓN CON LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

.- TRAUMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO POR APLASTAMIENTO CON COMPROMISO VASCULAR A NIVEL DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA QUIEN REQUIRIÓ SER LLEVADO A CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS (LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONÉ DERECHO - DESBORDAMIENTO CON REPARACIÓN TENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL DEFECTO DE COBERTURA CRITICO EN PIERNA DERECHA CON COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN SUB ATMOSFÉRICA), POR COMPLEJIDAD DE LESIÓN INGRESA A UNIDAD PARA MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA, CUENTA CON PARACLÍNICOS DE CONTROL POSQUIRÚRGICO CON DISCRETO DESCENSO DE HEMOGLOBINA (10.2 GR/DL), CON VARIABLES HEMODINÁMICAS DENTRO DE LIMITES NORMALES, DE MOMENTO SIN DÉFICIT NEUROVASCULAR DE EXTREMIDAD, DOLOR MODULADO, EN PLAN DE SER LLEVADO A NUEVO TIEMPO QUIRÚRGICO POR PARTE DE ORTOPEDIA EN 3 A 5 DÍAS SEGÚN EVOLUCIÓN CLÍNICA, POR AHORA CONTINUA MANEJO MEDICO ESTABLECIDO.

.- RESPIRATORIO: SIN SOPORTE DE OXIGENO, MECANICA RESPIRATORIA CON BUEN PATRON.

.- GASTROINTESTINAL: SIN DOLOR NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. NO REALIZA DEPOSICIÓN. BUEN CONTROL GLUCOMETRICO. TOLERA VIA ORAL PLENA.

.- RENAL; BUEN RITMO DIURÉTICO SIN EDEMAS - GASTO URINARIO PARA 24 HORAS 2.1 CC/KG/HR.

.- INFECCIOSO: SIN DESCOMPENSACIÓN CONTINUA AMPICILINA/SULBACTAM.

.- NEUROLÓGICO ALERTA SIN CRISIS, GLASGOW 15/15 SIN DATOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA.

PACIENTE CON PATOLOGIA TRAUMATICA ANTERIORMENTE DESCRITA QUIEN REQUIERE CONTINUAR MANEJO INTEGRAL EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, SE EXPLICA A LA MADRE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

2026-03-10 10:26	**PROFESIONAL:** marmulta - MARIA GISELL MURILLO TAMAYO	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

TERAPIA RESPIRATORIA DIA

PACIENTE AMBEREEM JACDIEL RAMOS BRACHO DE GENERO FEMENINO DE 6 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS MEDICOS ANOTADOS PREVIAMENTE EN LA HISTORIA CLINICA, ENCUENTRO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES DE SALUD EN GENERAL, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE SIN SOPORTE DE VASOPRESOR, SIN SEDOANALGESIA, EN EL SISTEMA NEUROLOGICO, GLASGOW 15/15, EN EL SISTEMA CARDIVASCULAR SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES SIGNOS VITALES: TA 102/77, FC 86, FR 24, EN EL SISTEMA PULMONAR SE ENCUENTRA SIN SOPORTE DE OXIGENO, FIO2 21%, SATURANDO ENTRE 97-99 A LA AUSCULTACION SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES SIN PRESENCIA DE RUIDOS SOBRE AGREGADOS, TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, PATRON RESPIRATORIO RITMICO TORACOABDOMINAL SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

OBJETIVOS:
MITIGAR ENFERMEDADES PULMONARES
FAVORECER LA REEXPANSION PULMONAR

INTERVENCIÓN FISIOTERAPEUTICA
--MONITORIA RESPIRATORIA
--POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER A 45°
--FISIOTERAPIA RESPIRARTORIA CON MOVILIZACIÓN DE REJA COSTAL
--ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TECNICA DE DESOBTRUCCION BRONQUIAL SIN MOVILIZAR SECRECIONES
--EJERCICIOS DE REEXPANSION PULMONAR CON INSPIRACIONES PROFUNDAS SOSTENIDAS 8 REPETICIONES
--INSPIRACIONES FRACCIONADAS Y SUSPIROS PROFUNDOS 8 REPETICIONES

PACIENTE TOLERA INTERVENCION, QUEDA ESTABLE DENTRO DE SU CUADRO CLÍNICO.

2026-03-10 22:51	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIO- PEDIATRIA - NOCHE -
DRA. DIANA DONNEYS (MD PEDIATRA) - FABIAN CHANTRÉ (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: NN-NN (AMBEREEM JACDIEL RAMOS BRACHO)
EDAD: 8 AÑOS
IDENTIFICACION: MS-VEN000316
FECHA DE NACIMIENTO: 08/03/2018
ORIGEN: VENEZUELA.
PROCEDENCIA: CALI - VALLE
ENTIDADA: SOAT
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 08/03/2026
FECHA DE INGRESO A UCIP: 08/03/2026

*DIAGNOSTICOS:
1.- TRAUMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO POR APLASTAMIENTO DE LA PIERNA DERECHA.
2.- LESIÓN VASCULAR DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA.
– POP (08/03/26) LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONE DERECHO
– POP (08/03/26) DESBORDAMIENTO CON REPARACIÓN TENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL DEFECTO DE COBERTURA CRITICO EN PIERNA DERECHA CON COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN SUB ATMOSFÉRICA

*CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA, RESPIRATORIA, NEUROLÓGICA CONTINUA NO INVASIVA
.- POP DE CIRUGÍA MAYOR
.- ALTO RIESGO DE FENÓMENOS TROMBÓTICOS
.- MANEJO DE DOLOR

*INVASIONES
.- CATÉTER PERIFÉRICO MSD - 08/03/2026

*SOPORTES:
-NO

*INFUSIONES:
- NO

*EVENTOS:
-POP DE LAVADO + DESBRIDAMIENTO DE PIERNA DERECHO
-SISTEMA DE VAC FUNCIONAL
-DOLOR MODULADO

* SUBJETIVO: PACIENTE EN COMPAÑIA DE SU MADRE QUIEN REFIERE QUE PASA BIEN EL DIA, TOLERA VIA ORAL, CON DOLOR CONTROLADO.

* OBJETIVO: PACIENTE EN CAMA, ALERTA, COLABORADOR, NO LUCE ÁLGIDO, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, SIN DÉFICIT NEUROVASCULAR DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO

* EXAMEN FÍSICO:
SE VALORA A PACIENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD

PESO 35 KG
TALLA 124 CM

VALORACIÓN NUTRICIONAL
PESO: 30 KG (P87, 1,10DE) (OMS 2006/2007)
TALLA: 124 CM (P28, -0,58DE) (OMS 2006/2007)
IMC: 19,51 KG/M2 (P97, 1,94DE) (OMS 2006/2007)

SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 101/68 MMHG (TAM 79 MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 112 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA 24 RPM
SATURACIÓN DE O2 98 % FiO2 21 %
TEMPERATURA 36.2 °C AFEBRIL EN 12 HORAS

BALANCE HÍDRICO EN 12 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 1590 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 1700 CC
BALANCE DEL DIA - 110 CC
BALANCE ANTERIOR: 253+
GU: 4.7 CC/KG/H
METABÓLICO: TOLERANDO VIA ORAL - NO REALIZA DEPOSICIONES EN LAS ULTIMAS 12 HORAS.

NORMOCONFIGURADO, OJOS SIMÉTRICOS PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, CONJUNTIVAS ROSADAS, ESCLERAS ANICTERICAS
ORL MUCOSAS HUMEDAS ROSADAS
CUELLO SIMÉTRICO NO ADENOPATIAS.
HEMODINAMICO RSCS RÍTMICOS NO AUSCULTO SOPLOS, PULSO CENTRAL Y PERIFÉRICO BUEN TONO LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS.
RESPIRATORIO: TÓRAX SIMÉTRICO, NO TIRAJES, CAMPOS PULMONARES VENTILADOS SIN AGREGADOS PULMONARES SIN SOPORTE DE OXIGENO.
GASTROINTESTINAL: ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE NO IMPRESIONA DOLOR A LA PALPACIÓN NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL NO MEGALIAS.
RENAL: MICCIÓN ESPONTÁNEA, SIN ALTERACIONES, NO EDEMAS.
EXTREMIDADES: A NIVEL DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO INMOVILIZACIÓN CON FÉRULA DE YESO, LLENADO CAPILAR DE LOS DEDOS DEL PIE Y PERFUSIÓN DISTAL CONSERVADA. SISTEMA VAC FUNCIONAL CON ESCASO PRODUCIDO.
METABÓLICO: TOLERANDO VIA ORAL , NO EMESIS, GLUCOMETRIA 158 - 129 - 164 MG/DL, NO REALIZA DEPOSICIONES .
HEMATOLÓGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS.
INFECCIOSO: SIN DISTERMIAS, CONTINUA TERAPIA ANTIMICROBIANA AMPICILINA /SULBACTAM.
NEUROLÓGICO: GLASGOW 15/15, ORIENTADA EN TIEMPO Y ESPACIO. SIN CRISIS.

* ANTIBIÓTICO:
.- AMPICILINA /SULBACTAM 1.8 GR CADA 6 HORAS FI: 08/03/2026

ANALISIS:
AMBER ESCOLAR DE 8 AÑOS, HOSPITALIZADA EN LA UNIDAD POR ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CARGA CINÉTICA CON POLITRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE PIERNA DERECHA CURSA POP DE LAVADO DESBRIDAMIENTO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. A LA VALORACIÓN CON LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

.- TRAUMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO POR APLASTAMIENTO CON COMPROMISO VASCULAR A NIVEL DE LA ARTERIA PERONEA DERECHA QUIEN REQUIRIÓ SER LLEVADO A CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS (LAVADO DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA GIIIB DE TIBIA Y PERONÉ DERECHO - DESBORDAMIENTO CON REPARACIÓN TENDINOSA EN COMPARTIMIENTOS ANTERIOR LATERAL Y POSTERIOR SUPERFICIAL DEFECTO DE COBERTURA CRITICO EN PIERNA DERECHA CON COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN SUB ATMOSFÉRICA), POR COMPLEJIDAD DE LESIÓN INGRESA A UNIDAD PARA MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA, CUENTA CON PARACLÍNICOS DE CONTROL POSQUIRÚRGICO CON DISCRETO DESCENSO DE HEMOGLOBINA (10.2 GR/DL), CON VARIABLES HEMODINÁMICAS DENTRO DE LIMITES NORMALES, DE MOMENTO SIN DÉFICIT NEUROVASCULAR DE EXTREMIDAD, DOLOR MODULADO, EN PLAN DE SER LLEVADO A NUEVO TIEMPO QUIRÚRGICO POR PARTE DE ORTOPEDIA EN 3 A 5 DÍAS SEGÚN EVOLUCIÓN CLÍNICA, POR AHORA CONTINUA MANEJO MEDICO ESTABLECIDO.

RESPIRATORIO: SIN SOPORTE DE OXIGENO, MECANICA RESPIRATORIA CON BUEN PATRON.

GASTROINTESTINAL: SIN DOLOR NI SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. NO REALIZA DEPOSICIÓN. BUEN CONTROL GLUCOMETRICO. TOLERA VIA ORAL PLENA.

RENAL; BUEN RITMO DIURÉTICO SIN EDEMAS - GASTO URINARIO PARA 12 HORAS 4.7 CC/KG/H

INFECCIOSO: SIN DESCOMPENSACIÓN, CON ALTO RIESGO DE INFECCIÓN, CONTINUA MANEJO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA/SULBACTAM.

NEUROLÓGICO ALERTA SIN CRISIS, GLASGOW 15/15 SIN DATOS DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA.

PACIENTE CON PATOLOGIA TRAUMÁTICA ANTERIORMENTE DESCRITA QUIEN REQUIERE CONTINUAR MANEJO INTEGRAL EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, SE EXPLICA A LA MADRE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

DIAGNOSTICOS DE EGRESO ASIGNADOS	
CODIGO	DIAGNOSTICO DE EGRESO
S822	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA

FECHA	RESUMEN DEL PLAN TERAPEUTICO
2026-03-08	16:08 julgraor - JULIANA GRAJALES ORTIZ ESPECIALIDAD: PEDIATRIA Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE PIERNA (AP LATERAL) **Obs: trauma en pierna derecha Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE TOBILLO (AP LATERAL Y ROTACION INTERNA) **Obs: trauma en tobillo derecho Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO **Obs: pre qx Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] **Obs: pre qx Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] **Obs: pre qx Solucitud Apoyo Dx: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS **Obs: se solicita Solucitud Apoyo Dx: NITROGENO UREICO **Obs: ss Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES **Obs: trauma en PIERNA DERECHA Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL **Obs: TRAUMA EN PIERNA DERECHA Solucitud Apoyo Dx: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS

**Obs: SS
Solucitud Apoyo Dx: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: SS
Solucitud Apoyo Dx: CALCIO IONICO
**Obs: SS
Solucitud Apoyo Dx: SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: SS
Solucitud Apoyo Dx: CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK]
**Obs: SS
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: PASAR EN BOLO
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-MORFINA 10MG/M SOLUCION INYECTABLE X 1ML-RYAN 10 MG / ML SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 10 MG / ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: -MORIFNA AMP 10 MG, ADM 1.2 MG EV AHORA

MEDICAMENTO FINALIZADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1.00 SOLUCION Cada 1 Dia(s) , VIA: INTRAVENOSA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1.00
OBSERVACIONES: PASAR EN BOLO
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 50ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: TOXOIDE TETANICO 40 UI/0.5ML SOLUCION INYECTABLE-DELTA 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAMUSCULAR, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE X 2ML-ECAR 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FINALIZADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 50ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1.00 SOLUCION Cada 1 Dia(s) , VIA: INTRAVENOSA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1.00
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: .

17:25 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Proc Qx: SECUESTRECTOMIA DRENAJE DESBRIDAMIENTO DE TIBIA Y PERONE
**Obs: FRACTURA ABIERTA GRADO III B CON DEGLOVING CIRCUNCFERENCAL SEVERO CASI TOTAL DEL 95 % DE PIERNA DERECHA

17:39 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Proc Qx: SECUESTRECTOMIA DRENAJE DESBRIDAMIENTO DE TIBIA Y PERONE
**Obs: FRACTURA ABIERTA GRADO III B CON DEGLOVING CIRCUNCFERENCAL SEVERO CASI TOTAL DEL 95 % DE PIERNA DERECHA

MATERIAL:
VAC TALLA L

*** URGNCIA VITAL ***

17:43 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Proc Qx: SECUESTRECTOMIA DRENAJE DESBRIDAMIENTO DE TIBIA Y PERONE
**Obs: FRACTURA ABIERTA GRADO III B CON DEGLOVING CIRCUNCFERENCAL SEVERO CASI TOTAL DEL 95 % DE PIERNA DERECHA

MATERIAL:
VAC TALLA L
CLAVO STEINMANN DE 2.5 #2
CLAVO STEINMANN DE 2 #2

*** URGNCIA VITAL ***

17:45 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
- CABECERA A 30?
- NADA POR VIA ORAL
- HARTMAN A 100 CC/H, IV.
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).
- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5).
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV.
- MORFINA 3 MG, C/4H, IV (SI EVA >4. MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE).
-OXIGENOTERAPIA A 1 L/MIN POR CANULA NASAL CONVENSIONAL.
- GLUCOMETRIAS CADA 6 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.

- MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES
- CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
- VALORACION POR ORTOPEDIA Y TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4

17:56 julgraor - JULIANA GRAJALES ORTIZ
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

Solicitud Proc No Qx: 109A01-INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 100ML-BAXTER 1 BOLSA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % BOLSA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: **

18:44 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO FORMULADO: AMPICILINA 1G + SULBACTAM 0.5G POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR VIAL-FARMALOGICA 1 VIAL - LAB. :VARIOS 3 VIAL Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1g/0,5mg VIAL, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: AMPICILINA 1G + SULBACTAM 0.5G POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR VIAL-FARMALOGICA 1 VIAL - LAB. :VARIOS 2 VIAL Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1g/0,5mg VIAL, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: PARACETAMOL 1000MG SOLUCION INYECTABLE 100ML-FRESENIUS 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1000mg SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
Glucometria : Cada 6 horas
MEDICAMENTO FORMULADO: LACTATO DE RINGER X 1000ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 3 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1000ml SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
Solicitud Proc No Qx: 939403-TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL
MEDICAMENTO REFORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1.00 SOLUCION Cada 1 Dia(s) , VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACI?N 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: PASAR EN BOLO
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 5 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: PASAR EN BOLO
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 5 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 4 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: .
MEDICAMENTO RE FORMULADO: DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE X 2ML-ECAR 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

18:49 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Interconsulta por: TRAUMATOLOGIA-ORTOPEDIA
**Obs: FRACTURA EXPUESTA GRADO IIIB DE TIBIA Y PERONE DERECHOS CON DEGLOVING, REQUIERE MANEJO URGENTE POR ORTOPEDIA PEDIATRICA

19:19 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: SE SOLICITA URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: CLORO
**Obs: SE SOLICITA URGENTE

19:24 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO FORMULADO: ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML SOLUCION INYECTABLE-SETAA PHARMA AMPOLLA - LAB. :VARIOS 2 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500mg/5ml SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 450 MG IV EN BOLO

19:56 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA
**Obs: RESERVA DE 2 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA Rh [ANTIGENO Rh D] POR MICROTECNICA
**Obs: RESERVA DE 2 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA
**Obs: RESERVA DE 2 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR

MICROTECNICA
**Obs: RESERVA DE 2 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA
**Obs: RESERVA DE 2 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS
**Obs: RESERVA DE 2 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS

20:56 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
- CABECERA A 30?
- NADA POR VIA ORAL
- BOLO DE SSN 300 CC (YA ADMINITRADO), LEV HARTMAN 80CC/HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).
- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5).
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV.
- MORFINA 1.5 MG, C/4H, IV (SI EVA >4. MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE).
- OXIGENOTERAPIA A 1 L/MIN POR CANULA NASAL CONVENSIONAL.
- GLUCOMETRIAS CADA 6 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
- MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES
- CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS

SE SOLCITA
RESERVADE 2 UGR PARA PROCEDIMIENTO DE ORTOPEDIA.

EN PROCESO
PROCEDIMIENTO POR ORTOPEDIA
VALORACION POR TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4

GRACIAS!

22:53 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL

23:12 hanlisbo - HANSEL STEVEN LIS BOLAÑOS
ESPECIALIDAD: ANESTESIOLOGIA

MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-PROPOFOL 1 % (10MG/M) SOLUCION INYECTABLE X 20ML-B BRAUN 200MG/20ML AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 8 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 200MG/20ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-REMIFENTANILO 2MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE VIAL-B BRAUN 2 MG POLVO INYECTABLE - LAB. :VARIOS 1 POLVO Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN VIAL, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-MIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUCION INYECTABLE X 3ML-FRESENIUS 15 MG / 3 ML SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 15 MG / 3 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

2026-03-09

01:26 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE PIERNA (AP LATERAL)
**Obs: DERECHA, CONTRO POP.

04:05 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

.

10:22 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

*PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
- CABECERA A 30?
- DESTETE DE OXIGENO
- INICIAR VIA ORAL DIETA BLANDA
- HARTMAN 80CC/HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).

- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5). CON HORARIO FI 8 DE MARZO 2026 1/ 5 D
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV. CON HOARIO
- MORFINA 3 MG, C/4H CON HORARO HASTA MA?ANA , IV (SI EVA >4. MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE 1,5 MG).
- GLUCOMETRIAS CADA 6 HORAS
- HORJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
- VALORACION DEL DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4
- PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
- ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
- MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DOLOR
- EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
- BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
- MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS

EN PROCESO
SEGUIMIENTO DE ORTOPEDIA
VALORACION POR TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4
-META DE NIRS SOMATICO MAYOR DE 60
GRACIAS!

20:28 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
- CABECERA A 30?
- SUSPENDER OXIGENO
- DIETA BLANDA
- HARTMAN 80CC/HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).
- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5). CON HORARIO FI 8 DE MARZO 2026 1/ 5 D
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV. CON HOARIO
- MORFINA 3 MG, C/4H CON HORARO HASTA MA?ANA , IV (SI EVA >4. MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE 1,5 MG).
- GLUCOMETRIAS CADA 6 HORAS
- HORJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
- VALORACION DEL DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4
- PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
- ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
- MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DOLOR
- EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
- BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
- MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS

EN PROCESO
SEGUIMIENTO DE ORTOPEDIA
VALORACION POR TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4
-META DE NIRS SOMATICO MAYOR DE 60
GRACIAS!

2026-03-10

09:59 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

NUEVA ORDEN MEDICA
.- MANEJO INTEGRAL EN UCIN
.- RESTO DE MANEJO IGUAL
GRACIAS !!!
Solicitud Proc No Qx: 106M01-INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO

10:23 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO - UCIN
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO
- CABECERA A 30?
- DIETA BLANDA
- HARTMAN 80 CC/HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).
- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5). CON HORARIO FI 8 DE MARZO 2026 2/5 D
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
- MORFINA 3 MG, C/4H CON HORARO HASTA MA?ANA , IV (SI EVA >4. MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE 1,5 MG).
SUSPENDER
- GLUCOMETRIAS CADA 6 HORAS
- HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
- VALORACION DEL DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4
- PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
- ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
- MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DOLOR
- EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
- BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
- MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS

EN PROCESO
SEGUIMIENTO DE ORTOPEDIA
VALORACION POR TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4
-META DE NIRS SOMATICO MAYOR DE 60
GRACIAS!

13:50 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO - UCIN
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO
- CABECERA A 30?
- DIETA BLANDA
- HARTMAN 80 CC/HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).
- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 1/5). CON HORARIO FI 8 DE MARZO 2026 2/5 D
- PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
- GLUCOMETRIAS CADA 8 HORAS
- HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS
- VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA.
- MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
- VALORACION DEL DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4
- PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
- ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
- MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DOLOR
- EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
- BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
- MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS

EN PROCESO
SEGUIMIENTO DE ORTOPEDIA
VALORACION POR TRABAJO SOCIAL

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM: >70 MMHG.
-DIURESIS: >1-3 CC/KG/H.
-EVA: <4
-META DE NIRS SOMATICO MAYOR DE 60
GRACIAS!

21:54 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO - UCIN
PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2.

- CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO
- CABECERA A 30?
- DIETA COMUN
- HARTMAN 80 CC/HORA ** SUSPENDER**
- AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026).

	- DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 2/5). CON HORARIO FI 8 DE MARZO 2026 2/5 D - PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV. CON HORARIO - GLUCOMETRIAS CADA 24 HORAS - HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS - VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA. - MONITORIA NIRS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. - VALORACION DEL DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4 - PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N. - ACOMPA?ANTE PERMANENTE. - MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DOLOR - EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA - BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD - MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS EN PROCESO SEGUIMIENTO DE ORTOPEDIA NUEVO PROCEDIMIENTO TENTATIVO ENTRE 12-13 DE MARZO *METAS TERAPEUTICAS: -TAM: >70 MMHG. -DIURESIS: >1-3 CC/KG/H. -EVA: <4 -META DE NIRS SOMATICO MAYOR DE 60 GRACIAS!
2026-03-11	07:33 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO *PLAN TERAPEUTICO - UCIN PESO: 35 KG. SC: 1.2 M2. - CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO - CABECERA A 30? - DIETA COMUN - TAPON SALINADO - AMPICILINA SULBACTAM 1800 MG, C/6H, IV (CON BASE EN AMPICILINA) . (FI: 08/03/2026). - DIPIRONA 500 MG, C/6H, IV. (D: 2/5). CON HORARIO FI 8 DE MARZO 2026 3/5 D - PARACETAMOL 350 MG, C/6H, IV. CON HORARIO - GLUCOMETRIAS CADA 24 HORAS - HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS - VIGILANCIA NEUROVASCULAR DE LA PIERNA DERECHA. - VALORACION DEL DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4 - PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N. - ACOMPA?ANTE PERMANENTE. - MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DOLOR - EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA - BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD - MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS EN PROCESO SEGUIMIENTO DE ORTOPEDIA *METAS TERAPEUTICAS: -TAM: >70 MMHG. -DIURESIS: >1-3 CC/KG/H. -EVA: <4 -META DE NIRS SOMATICO MAYOR DE 60 GRACIAS!

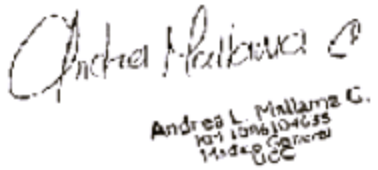
NO HAY RESULTADOS DE EXAMEN FISICO

REVISION POR SISTEMA DEL PACIENTE

SISTEMA	OBSERVACION	FECHA REGISTRO
Neurologico	NIEGA	08/03/2026 16:07
Nervioso Central y Periferico	NIEGA	08/03/2026 16:07
Organos de los Sentidos	NIEGA	08/03/2026 16:07
CardioVascular	NIEGA	08/03/2026 16:07
Respiratorio	NIEGA	08/03/2026 16:07
GastroIntestinal	NIEGA	08/03/2026 16:07
GenitoUrinario	NIEGA	08/03/2026 16:07
OsteoMuscular	NIEGA	08/03/2026 16:07

Esfera Mental	NIEGA	08/03/2026 16:07
Piel	NIEGA	08/03/2026 16:07
Sistema Endocrino	NIEGA	08/03/2026 16:07
General	NIEGA	08/03/2026 16:07

YO ANDREA LIZETH MALLAMA CARDENAS CERTIFICO QUE EL SEï¿½OR AMBEREEM JACDIEL RAMOS BRACHO IDENTIFICADO CON MENOR SIN IDENTIFICACION NUMERO VEN000316, HA SUFRIDO DAï¿½O EN SU INTEGRIDAD FISICA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO



PROFESIONAL : ANDREA LIZETH MALLAMA CARDENAS

CC - 1086104635 - T.P 1086104635

ESPECIALIDAD - MEDICINA GENERAL

Imprimiï¿½: ANDREA LIZETH MALLAMA CARDENAS - andmalca

Fecha Impresiï¿½n : 2026/3/11 - 08:03:11